

materials/2026-08-21-health-financing- FULLTEXT.pdf

===== หน้า fin_ocr.fin-01.txt ===== **มูมซ้ายบน (โลโก้/ชื่อหน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

กล่องข้อความสีเหลืองตรงกลาง (หัวเรื่องหลัก): ระบบการจ่ายเงินชดเชย ตามระบบ กองทุนในระบบสุขภาพ

กล่องข้อมูลผู้บรรยาย (มุมขวาล่าง): ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชต วงรอต ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Phichet.won@mahidol.ac.th

===== หน้า fin_ocr.fin-02.txt ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: ปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสุขภาพ

คอลัมน์ซ้าย (หัวข้อย่อย): ปัจจัยนำเข้า

รายการ (จากบนลงล่าง): - กำลังคนด้านสุขภาพ - สถานบริการด้านสุขภาพ - ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ - การเงินการคลังด้านสุขภาพ

กล่องตรงกลาง: การจัดระบบบริการสุขภาพ

คอลัมน์ขวา (หัวข้อย่อย): ผลลัพธ์

รายการ (จากบนลงล่าง): - การเข้าถึงบริการสุขภาพ - ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการสุขภาพ - ความเป็นธรรมของระบบบริการสุขภาพ

===== หน้า fin_ocr.fin-03.txt ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่อง (กลางบน): ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2567

ฝั่งซ้ายของวงกลม: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ การอุปโภคบริโภค 13.3% 2,963 บาท (ภาษี ดอกเบี้ย สลากกินแบ่ง เบี้ยประกัน ฯลฯ)

กลางวงกลม: รวมทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน 22,282 บาท

ฝั่งขวาของวงกลม: 86.7% ค่าใช้จ่าย อุปโภคบริโภค 19,319 บาท

แบ่งตามหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้

แถวการ์ดที่ 1 (จากซ้ายไปขวา): อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ 8,005 บาท (35.9%)

ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ 4,736 บาท (21.3%)

ยานพาหนะ/การเดินทาง 3,713 บาท (16.7%)

แถวการ์ดที่ 2: เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ของใช้ส่วนบุคคล 1,036 บาท (4.6%)

ค่าใช้จ่ายการสื่อสาร 826 บาท (3.7%)

ค่าใช้จ่ายการศึกษา 293 บาท (1.3%)

แถวการ์ดที่ 3: เวชภัณฑ์/ค่ารักษา 272 บาท (1.2%)

การบันเทิง/จัดงานพิธี 242 บาท (1.1%)

กิจกรรมทางศาสนา 197 บาท (0.9%)

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย, กองสถิติสังคม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567.สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2567.

==== หน้า fin_ocr.fin-04.txt ==== **มุมบนซ้าย (โลโก้/หน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อมูลกลางบน (กรอบสีทอง): ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตาม ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2562 - 2567

มุมขวาล่างบนของตาราง: (หน่วย : บาท)

แถวข้อมูล (เรียงจากบนลงล่าง):

ปี 2567 2,963 | 15,768 | 3,551 13.3% | 70.8% | 15.9% 22,282

ปี 2566 3,050 | 16,664 | 3,981 12.9% | 70.3% | 16.8% 23,695

ปี 2565 2,842 | 15,734 | 3,796 12.7% | 70.3% | 17.0% 22,372

ปี 2564 2,814 | 14,339 | 4,464 13.0% | 66.3% | 20.7% 21,616

ปี 2563 2,769 | 15,027 | 3,533 13.0% | 70.5% | 16.5% 21,329

ปี 2562 2,797 | 14,486 | 3,460 13.5% | 69.8% | 16.7% 20,742

คำอธิบายสัญลักษณ์ (legend) ด้านล่างตาราง: [สีเหลี่ยมสีน้ำตาลเข้ม] ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค [สีเหลี่ยมสีส้ม] ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค (ที่ครัวเรือนซื้อหรือจ่ายเงินเอง) [สีเหลี่ยมสีส้มอ่อน] ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค (ที่ครัวเรือนไม่ได้ซื้อหรือจ่ายด้วยเงินของตนเอง)

มุลำงซ้าย (แหล่งที่มา พร้อมไอคอนกราฟ): ที่มา: กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย, กองสถิติสังคม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2567.

==== หน้า fin_ocr.fin-05.txt ==== **มุลำงซ้าย (โลโก้/หน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (กล่องกรอบฟ้า): แนวโน้มงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข และสัดส่วนต่องบประมาณของประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2567

กล่องคำอธิบายสัญลักษณ์ (Legend): งบประมาณรายจ่ายของประเทศ (ล้านบาท)

ร้อยละของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับจัดสรรต่องบประมาณรายจ่ายของประเทศ (%)

แกนตั้งซ้าย: ล้านบาท 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

แกนตั้งขวา: ร้อยละ (%) 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

แกนนอน (ปีงบประมาณ): 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

ข้อมูลจุดกราฟเส้นสีเหลือง (งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ล้านบาท) เรียงตามปี:
2,380,000 2,400,000 2,525,000 2,575,000 2,776,000 2,923,000 2,900,000 3,000,000 3,200,000 3,285,962 3,100,000 3,185,000 3,480,000

ข้อมูลจุดกราฟเส้นสีฟ้า (ร้อยละของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข) เรียงตามปี: 8.4 8.7 8.8 8.8 8.9 8.7 9.0 9.0 8.7 8.9 9.6 9.3 9.1

มุล่งข่ย (กีมข้มูล): กีม: รยงนผลกรประเมณยุทธศตรควณเป็นเลศ 4 ด้น
ของกรทรวงสธรณสุข ป้งบประมณ 2567

===== หน้า fin_ocr.fin-06.txt ===== **มุล่งข่ย (ลลล/หน่วยงน):** Mahidol
University Faculty of Nursing

หวัเร้ง (แลบเล้ง): อตรผู้ป่วยนอกต้อพันประชกร พ.ศ. 2555-2566 (ไม่รวม
กรทรวงมหนค)

แลนต้ง (ข่ยของกรฟ): อตรต้อ 1,000 ประชกร 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

จุดข้อมูลบนเส้นกรฟ (จกข่ยไปขว): 3,116.4 2,916.6 2,836.8 3,159.9 3,732.9
3,691.2 3,392.7 4,030.7 3,499.5 2,934.8 3,387.6 3,697.3

แลนนอน (ปี พ.ศ.): 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2565 2566 พ.ศ.

กีม (ด้นล่งกรบกรฟ): กีม: รยงนผลกรประเมณยุทธศตรควณเป็นเลศ 4 ด้น
ของกรทรวงสธรณสุข ป้งบประมณ 2567

===== หน้า fin_ocr.fin-07.txt ===== **มุล่งข่ย (ลลล/หน่วยงน):** Mahidol
University Faculty of Nursing

หวัข้ (แลบเล้ง ก้งกล่งบน): อตรผู้ป่วยในต้อแลนประชกร พ.ศ. 2555-2566

แลนต้ง (ข่ยของกรฟ): อตรต้อ 100,000 ประชกร

ค่านแลน (จกบนลงล่ง): 40,000 / 30,000 / 20,000 / 10,000

จุดข้อมูลบนเส้นกรฟ (จกข่ยไปขว): 27,490.0 27,850.0 25,280.0 29,410.0
30,364.0 30,230.0 31,372.0 32,678.8 32,009.8 33,586.0 33,173.6 38,703.1

แลนนอน (ปี พ.ศ., จกข่ยไปขว): 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2563 2564 2565 2566

ป่ยกักกับแลนนอน (มุล่งข่ยของกรฟ): พ.ศ.

แลบล่งสุด (กีมของข้มูล): กีม: รยงนผลกรประเมณยุทธศตรควณเป็นเลศ 4
ด้นของกรทรวงสธรณสุข ป้งบประมณ 2567

===== หน้า fin_ocr.fin-08.txt ===== **มุล่งข่ย (ลลล):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หวัข้หลัก (กล่งบน): สถน: 3 กรทรวงสุขภพ

การ์ดที่ 1 (ซ้าย): กองทุนประกันสังคม

งบประมาณ 846,544 ล้านบาท (รัฐสมทบ 33.3%)

ผู้มีสิทธิ/ล้านคน 10.4

ค่าใช้จ่าย/คน/บาท 2,105

เครื่องหมาย + (ระหว่างการ์ด 1 กับ 2)

การ์ดที่ 2 (กลาง): หลักประกันสุขภาพ

งบประมาณ 120,846 ล้านบาท (รัฐสมทบ 100%)

ผู้มีสิทธิ/ล้านคน 47.1

ค่าใช้จ่าย/คน/บาท 2,755

เครื่องหมาย + (ระหว่างการ์ด 2 กับ 3)

การ์ดที่ 3 (ขวา): กองทุนข้าราชการ

งบประมาณ 62,195 ล้านบาท (รัฐสมทบ 100%)

ผู้มีสิทธิ/ล้านคน 4.9

ค่าใช้จ่าย/คน/บาท 11,000-12,000

ที่มา (ล่างซ้าย): ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ” รับความท้าทายในอนาคต. HSRI Forum. 2555; 1(6): 3-7.

===== หน้า fin_ocr.fin-09.txt ===== **หัวข้อสไลด์ (มุมบนขวา):** 09 / 24

โลโก้/ส่วนหัว (มุมบนซ้าย): Mahidol University — Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (กลางบน): ระบบกองทุนสุขภาพ

ตาราง:

ระบบประกันสุขภาพ	ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (CSMBS)	ระบบประกันสังคม (SSS)	ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCS)
แนวคิด	รัฐสวัสดิการสำหรับผู้ทำงานภาครัฐ	ความมั่นคงด้านสังคม	สิทธิขั้นพื้นฐานประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สัดส่วนผู้มีสิทธิ (ปี พ.ศ.2551)	8%	15.8%	75%
แหล่งเงินทุน	งบประมาณรัฐ	สมทบจากรัฐ นายจ้าง และลูกจ้างฝ่ายละเท่ากัน	งบประมาณรัฐ

แหล่งที่มา (ล่างสุดของสไลด์): ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ” รับความท้าทายในอนาคต. HSRI Forum. 2555; 16(6): 3-7.

==== หน้า fin_ocr.fin-10.txt ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อกลาง (แถบเหลือง): ระบบกองทุนสุขภาพ

ตาราง 4 คอลัมน์ 3 แถว:

หัวตาราง: | ระบบประกันสุขภาพ | ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (CSMBS) | ระบบประกันสังคม (SSS) | ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCS) |

แถวที่ 1 (ไอคอนโล่): - **สิทธิประโยชน์** - รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ใน ตามประกาศกรมบัญชีกลาง - รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ใน ตามเกณฑ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน - รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วยนอก/ใน ตามเกณฑ์ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.

แถวที่ 2 (ไอคอนคลิปบอร์ด): - **เงื่อนไขการใช้บริการ** - สถานพยาบาลรัฐแห่งใดก็ได้ตามอิสระ และใช้ sw.เอกชนได้ตามประกาศ - เฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนคู่สัญญาที่ขึ้นทะเบียน ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกสถานบริการ - เฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนคู่สัญญาที่ขึ้นทะเบียนด้วย และสถานพยาบาลในเครือข่าย

แถวที่ 3 (ไอคอนเหรียญ): - **รูปแบบวิธีการจ่ายเงิน** - • ผู้ป่วยนอก ตามปริมาณบริการและราคาที่เรียกเก็บย้อนหลัง • ผู้ป่วยในตามรายป่วยในอัตราที่กำหนด (กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม) - เหม่าจ่ายรายหัวรวมสำหรับบริการผู้ป่วยนอกและใน และจ่ายเพิ่มเป็นรายกรณี - • เหม่าจ่ายรายหัวสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และผู้ป่วยนอก • งบประมาณจำกัด วงเงินรวมถ่วงน้ำหนักตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

ล่างซ้าย (แหล่งที่มา): ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ” รับความท้าทายในอนาคต. HSRI Forum. 2555; 1(6): 3-7.

มุมล่างขวา: 10

==== หน้า fin_ocr.fin-11.txt ==== **หัวเรื่อง (บนสุด):** ความสำคัญของระบบการจ่ายค่าบริการสุขภาพ

โลโก้ (มุมซ้ายบน): Mahidol University / Faculty of Nursing

ข้อ 1 (ไอคอนคน+โล่): ระบบการจ่ายค่าบริการ (provider payment mechanisms) เป็นหนึ่งใน “กลไกหลักของการเงินสุขภาพ” ตามกรอบขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมผู้ให้บริการ คุณภาพบริการ และความยั่งยืนทางด้านการคลังของประเทศ

ข้อ 2 (ไอคอนเป่าธนู): การกำหนดวิธีจ่ายค่าตอบแทนจะสร้างแรงจูงใจ (incentives) ให้ผู้ให้บริการกระทำในทิศทางที่ต้องการหรือไม่ต้องการ?

ข้อ 3 (ไอคอนคลิปบอร์ด+เหรียญ): รูปแบบการจ่ายค่าบริการสุขภาพ (payment methods) มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการ การเลือกรูปแบบต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพ ความเสมอภาค และต้นทุนรวมของระบบสุขภาพด้วย

อ้างอิง (4 รายการ) (ล่างสุด):

1 World Health Organization. Health financing: provider payment mechanisms. Geneva: WHO; 2022.

2 Cashin C, Sparkes S, Bloom D. Aligning public financial management and health financing. WHO; 2017.

3 Langenbrunner J, Cashin C. Designing and implementing health care provider payment systems. World Bank; 2009.

4 Barnum H, Kutzin J, Saxenian H. Incentives and provider payment methods. Int J Health Plann Manage. 1995;10:23-45.

==== หน้า fin_ocr.fin-12.txt ==== **มุมบนซ้าย (โลโก้/หน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (บนขวา): การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนให้สถานบริการ

กล่องด้านบน (กล่องใหญ่): ● งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพชี้ชัดว่า ‘การจ่ายค่าตอบแทน (payment) ส่งผลต่อพฤติกรรมบริการ (behavior)’

กล่องที่ 1 (ซ้าย): ❶ หากจ่ายตามปริมาณบริการ (volume-based เช่น FFS)
————— จะทำให้ปริมาณการให้บริการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กล่องที่ 2 (กลาง): ❷ หากจ่ายแบบเหมาจ่าย (capitation) ————— จะลดปริมาณบริการลง แต่เพิ่มบทบาทการป้องกันโรค

กล่องที่ 3 (ขวา): ❸ หากจ่ายแบบ prospective เช่น DRG ————— จะทำให้โรงพยาบาลใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

แถบล่างสุด (ที่มา): ที่มา: จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2544. Health Insurance System Research Office. Thai DRG Version 6. Bangkok; 2020.

===== หน้า fin_ocr.fin-13.txt ===== **หัวเรื่อง (บนสุด):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: การจ่ายตามบริการ (Fee-for-service: FFS)

รายการที่ 1: จ่ายตามบริการ (Fee-for-service) การจ่ายค่าตอบแทนในมูลค่าและตามจำนวนที่ได้ให้บริการไป เช่น กองทุนสวัสดิการรักษาท้องถิ่น (CSMBS)

รายการที่ 2: เป็นระบบที่จ่ายเงินตามรายการบริการที่ทำจริง เช่น ตรวจเลือดหนึ่งครั้งจ่ายหนึ่งครั้ง ใช้แพร่หลายมากในระบบสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และในระบบเอกชนทั่วโลก

รายการที่ 3: สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างกัน ตามส่วนผสมของการบริการที่มีความแตกต่างกัน

รายการที่ 4: เพิ่มปริมาณบริการและการเข้าถึงกันที่ เพราะยิ่งให้บริการมาก ยิ่งได้เงินมาก

รายการที่ 5: สนับสนุนบริการซับซ้อน เช่น MRI, endoscopy สะท้อนต้นทุนจริงของบริการ ทำให้สถาบันสามารถลงทุนด้านเทคโนโลยีได้

===== หน้า fin_ocr.fin-14.txt ===== **มุมนบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: การจ่ายตามบริการ (Fee-for-service: FFS)

ข้อ 1: สร้างแรงจูงใจให้บริการเกินจำเป็น (overuse) เพื่อเพิ่มรายได้ของหน่วยบริการ เช่น การสั่งตรวจ CT/MRI โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิก

ข้อ 2: ต้นทุนระบบสูง ควบคุมยาก เช่น สหรัฐฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสุขภาพสูงที่สุดในโลก แต่ผลลัพธ์โดยรวมไม่ได้ดีที่สุด

ข้อ 3: ไม่ส่งเสริมงานป้องกันโรค เนื่องจากไม่สามารถคิดค่าบริการจากกิจกรรม ที่มองไม่เห็นผลลัพธ์ทันที

ข้อ 4: กระตุ้น Low-value care เช่น การสั่งยา/ตรวจที่ไม่เพิ่มคุณค่าแก่ผู้ป่วย

ข้อ 5: มีแนวโน้มที่จะไม่ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาในสถานบริการที่เหมาะสม

===== หน้า fin_ocr.fin-15.txt ===== **หัวเรื่อง (บนสุด):** Mahidol University
Faculty of Nursing

การจ่ายแบบ Fee Schedule

1 เป็นระบบที่ “กำหนดราคาค่าบริการล่วงหน้า” โดยอิงต้นทุนมาตรฐาน และโครงสร้างราคา ใช้มากในบางประเทศ เช่น ค่าคลอดบุตร ค่าทำฟัน

2 โปร่งใส ตรวจสอบง่าย คาดการณ์งบประมาณได้ง่าย

3 ควบคุมราคาได้ดี ลดความเหลื่อมล้ำของราคาที่หน่วยบริการกำหนดเอง

4 หาก “ราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริง” อาจส่งผลให้โรงพยาบาล ขาดทุน จำเป็นต้องปรับปรุงราคาอย่างสม่ำเสมอเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว

ที่มา: Barber SL, Lorenzoni L, Ong P. Price setting in health care. WHO; 2019. | Medicare Payment Advisory Commission. Fee schedule update. Washington DC; 2020.

===== หน้า fin_ocr.fin-16.txt ===== **มุมมองซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก: การจ่ายเหมาจ่ายต่อครั้ง (Per-Visit Payment)

กล่องซ้าย (ไอคอนคลิปปอร์ด): เหมาจ่ายต่อครั้ง จ่ายคงที่ต่อการให้บริการแต่ละครั้ง

รายการฝั่งขวา:

1 การจ่ายค่าตอบแทนในแบบเหมาจ่ายในอัตราคงที่ต่อการให้บริการแต่ละครั้ง โดยไม่มีการพิจารณารายละเอียดและประเภทของการบริการ

2 ลดความยุ่งยากทางเอกสาร ลดการตรวจซ้ำที่ไม่จำเป็น

3 อาจเกิด under-service

4 ไม่เหมาะกับผู้ป่วยซับซ้อนสูง

5 ไม่มีแรงจูงใจพัฒนาคุณภาพบริการ

===== หน้า fin_ocr.fin-17.txt ===== **หัวข้อสไลด์:** การจ่ายเป็นเงินเดือน (Salary payment)

โลโก้บนซ้าย: Mahidol University, Faculty of Nursing

กล่องซ้าย (ไอคอนโป่งขึ้น): ประโยชน์

กล่องขวา ข้อ 1-4:

1. การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมจ่ายเป็นรายเดือนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้ป่วยที่ดูแล หรือจำนวนครั้งที่ให้บริการ
2. บริหารจัดการง่าย จำกัดวงเงินได้ งบประมาณไม่บานปลาย
3. สร้างเสถียรภาพของบุคลากรสุขภาพ
4. เหมาะกับระบบปฐมนิเทศและงานส่งเสริมสุขภาพที่ไม่สามารถคิดค่าบริการเป็นขั้นได้

กล่องซ้าย (ไอคอนโป่งลง): ข้อจำกัด

กล่องขวา ข้อ 5-7:

1. ลดแรงกระตุ้นในการลด-เพิ่มการจัดบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อควบคุมต้นทุน
2. ขาดแรงจูงใจในการสร้างผลผลิต ระบบการบริการอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ การให้บริการอาจจะได้น้อยเกินความจำเป็น
3. การกำหนดค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือนที่ต่ำเกินไปอาจจะทำให้เกิดการย้ายงานของบุคลากร

===== หน้า fin_ocr.fin-18.txt ===== **มุมนบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: การจ่ายตามรายหัว (Capitation Payment)

กล่องซ้าย (แนวคิด): แนวคิด

เป็นการจ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้า ตามรายหัวของผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการให้บริการ

กล่องขวา (ข้อดี): ข้อดี

1. เป็นการจ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้าตามรายหัวของผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการให้บริการ
2. บริการจัดการง่าย ลดกระบวนการในการเบิกจ่าย (Claim processing)
3. กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการบริหารจัดการ และการจัดบริการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผู้ลงทะเบียน
4. ส่งเสริมการป้องกันโรคและการดูแลตลอดกระบวนการ (continuity of care)
5. ส่งเสริมระบบปฐมภูมิ (primary care strengthening)
6. กระตุ้นให้ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (chronic care)
7. ผู้ให้บริการจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการเพื่อลดการใช้บริการ
8. จำกัดงบประมาณได้อย่างแม่นยำ

ด้านล่างสุด (ที่มา): ที่มา: National Health Security Office. Payment systems under the Universal Coverage Scheme. Bangkok; 2021.

==== หน้า fin_ocr.fin-19.txt ==== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: การจ่ายตามรายหัว (Capitation Payment)

แถบเตือน: ⚠ ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด

ข้อ 1: ต้องมีการศึกษา Health risk indicators อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการรายหัวมีความเพียงพอ

ข้อ 2: สถานบริการอาจจะให้บริการต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการ การควบคุมคุณภาพมีความจำเป็นสูง

ข้อ 3: แนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจะไม่เกิดขึ้น หากระบบไม่ได้ส่งเสริมให้ลงทะเบียนในระยะยาว

ข้อ 4: ต้องมีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ซื้อบริการมีการกำหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายรายหัวได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

==== หน้า fin_ocr.fin-20.txt ==== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (บนขวา): บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

ตาราง:

หัวตาราง: ประเภทบริการ | จำนวนเงิน/ปี (บาท)

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป — 1,279.31
2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป — 1,440.03
3. บริการกรณีเฉพาะ — 373.67
4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค — 455.39
5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ — 18.40
6. บริการการแพทย์แผนไทย — 17.50
7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมของหน่วยบริการ) — 128.69
8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ — 3.84
9. บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ — 2.00

แถวรวม (ล่างสุดของตาราง): รวม (บาทต่อผู้มีสิทธิ) — 3,719.23

==== หน้า fin_ocr.fin-21.txt ==== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

ข้อความใต้หัวข้อ: เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปทุกรายการ รวมค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กล่องสี่เหลี่ยม (กลาง): ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,279.31 บาทต่อผู้มีสิทธิ

กล่องซ้าย (สีฟ้า): จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (1,270.31 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

1. จ่ายให้หน่วยบริการประจำตามจำนวนผู้มีสิทธิ โดย สังกัด สป.สร.ใช้ผู้มีสิทธิ ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนการจ่าย สังกัดอื่นๆ เป็นไปตามผู้มีสิทธิรายเดือน
2. หลักเกณฑ์การจ่าย จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว โดยคำนวณ อัตรา จ่ายต่อผู้มีสิทธิ • 80% คำนวณด้วยโครงสร้างอายุประชากรระดับจังหวัด และให้อัตราต่างกันไม่เกิน ค่าเฉลี่ย $\pm 10\%$ • 20% คำนวณด้วยอัตราเท่ากันทุกกลุ่มอายุ

กล่องขวา (สีชมพู/บานเย็น): จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (9.00 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

• จัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขตตามจำนวนผู้มีสิทธิ • หลักเกณฑ์การจ่าย รวมบริการใน รายการการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รื้อตึง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-22.txt ===== **มูมบนชัย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไ

ข้อความใต้หัวข้อ: เป็นคำใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไ

กล่องสี่เหลี่ยม/เหลือง (กึ่งกลาง): ค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไ **1,440.03** บาทต่อผู้มีสิทธิ

กล่องซ้าย (สีน้ำเงิน หัวข้อ): 100 ลบ. บริหารจัดการระดับประเทศ

แนวทางการจ่าย: - จ่ายเพิ่มเติม สำหรับบริการในเขตที่อัตราจ่ายระดับเขต ไม่ถึง 8,350 บาทต่อ adjRW ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรม- การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหาร จัดการกองทุน กำหนด - ถ้าเงินเหลือจ่ายให้หน่วยบริการตามผลงาน

กล่องขวา (สีชมพู/ม่วง หัวข้อ): ส่วนที่เหลือ บริหารจัดการระดับเขต จัดสรร Global budget ระดับเขต

แนวทางการจ่าย: ใช้ DRG v5

1. การเข้ารับบริการตามมาตรา 7 (รวม UCEP) สำรองเตียง การใช้บริการนอกเขต และกรณีเด็กแรกเกิดที่น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม หรือเด็กแรกเกิดที่ป่วย สภานี้ ODS & MIS และ Home Chemo ตามราคาที่กำหนด
2. การใช้บริการในเขต (รวมเด็กแรกเกิดน้ำหนักมากกว่า 1,500 กรัม, ODS & MIS, และ Home Chemo และรวมกรณีที่เขตจะกำหนดอัตราเฉพาะเขต)
 - จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,350 บาทต่อ adjRW เท่ากันทุกเขต (ในระหว่างปี อาจปรับอัตราจ่ายเพิ่ม ตามประมาณการผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ถือเป็นอัตราจ่ายเบื้องต้น)
 - สิ้นปี หากมีเงินเหลือ แต่ละเขตจ่ายเพิ่มเติมตามผลงานของแต่ละหน่วยบริการ
 - ถ้าอัตราต่ำกว่า 8,350 บาทต่อ adjRW ให้ใช้เงินบริหารจัดการระดับประเทศ จ่ายให้ได้ที่อัตรา 8,350 บาทต่อ adjRW

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รื้อตึง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-23.txt ===== **หัวเรื่อง (บน):** 3. บริการกรณีเฉพาะ

เนื้อหาในกล่อง: เป็นบริการที่การจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบปกติจะทำให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อผู้รับบริการ (ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ) และผู้ให้บริการ (ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง) โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ไม่เกินร้อยละ 12 ของงบค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รื้อฟื้นตั้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

==== หน้า fin_ocr.fin-24.txt ==== **มูมบนชัย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวเรื่องบนขวา (สีเหลือง): 3. บริการกรณีเฉพาะ

กรอบหัวข้อย่อย (เส้นขอบสีเหลือง): หลักเกณฑ์การบริหารจัดการบริการกรณีเฉพาะ

รายการที่ 01 (พื้นหลังฟ้าอ่อน ไอคอนกลุ่มคนมีโล่): 01 การรวมความเสี่ยง (Risk pooling) เพื่อประกันการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และหรือมีผู้ป่วยไม่มาก

รายการที่ 02 (พื้นหลังครีมอ่อน ไอคอนจับมือ): 02 ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร (Central bargaining and/or central procurement)

รายการที่ 03 (พื้นหลังฟ้าอ่อน ไอคอนคลิปบอร์ดมีเครื่องหมายกากบาท): 03 ประกันการได้รับบริการบางรายการที่มีความจำเป็น เช่น บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเครือข่าย บริการที่เป็นนโยบายสำคัญ

รายการที่ 04 (พื้นหลังครีมอ่อน ไอคอนหมุดแผนที่): 04 การคำนึงถึงความแตกต่างของปัญหาระดับพื้นที่

ด้านล่างสุด (กรอบสีดำ ขอบเหลือง): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รื้อฟื้นตั้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

==== หน้า fin_ocr.fin-25.txt ==== **[โลโก้] Mahidol University Faculty of Nursing**

3. บริการกรณีเฉพาะ

1. กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำเป็น

- 1.1 การบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด (OP-AE ข้ามจังหวัด)
 - 1.2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกกรณีมาตรา 7 ที่สถานบริการอื่น
 - 1.3 การบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อข้ามจังหวัด (OP refer ข้ามจังหวัด)
 - 1.4 ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ
 - 1.5 กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ/ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม/ กรณีผู้ป่วยในที่ได้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนลงทะเบียนสิทธิ/ สำรองเตียง
-

2. กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ

- 2.1 ยาละลายลิ้มเลือด (STEMI, Stroke)
 - 2.2 บริการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Chemo/ Radio-OP&IP)
 - 2.3 บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจก พร้อมเลนส์ (Cataract)
 - 2.4 ก้นตกรรุมจัดฟันและฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่
 - 2.5 บริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง กรณีที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของประชาชน
-

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์ร้านตั้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-26.txt ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (สีเหลือง): 3. บริการกรณีเฉพาะ

กล่องที่ 1 (สีน้ำเงิน): 3. กรณีเพื่อลดความเสี่ยง ด้านการเงินของหน่วยบริการ

- 3.1 รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instrument-OP&IP)
- 3.2 การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyperbaric oxygen therapy)
- 3.3 การจัดหาดวงตาสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Corneal transplantation)

3.4 การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ (Liver transplantation ในเด็ก, Heart transplantation, Hematopoietic stem cell transplantation)

กล่องที่ 2 (สีชมพู/แดง): 4. กรณีจำเป็นต้องกำกับ การใช้บริการอย่างใกล้ชิด

4.1 ค่าบริการสารเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Treatment: MMT)

4.2 ยาที่จำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง (ยา จ (2), ยา CL และยากำพร้า)

กล่องที่ 3 (สีเขียว): 5. กรณีที่ต้องบริหาร แบบเฉพาะโรค

5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)

5.2 การดูแลผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis)

5.3 การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

5.4 การดูแลผู้ป่วยโรคหายาก สำหรับโรคที่มีความผิดปกติของสารโมเลกุลเล็ก (Disorders of small molecules)

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์ринตัง แอนด์พับลิชชิง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-27.txt ===== **หัวเรื่อง (บนซ้าย โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (บนขวา): 4. การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ข้อความย่อหน้าบน: เป็นคำใช้ง่าย สำหรับการจัดบริการสาธารณสุขด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ให้โดยตรง แก่บุคคลสำหรับประชาชนไทยทุกคน ภายใต้ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนี้

กล่องหมายเลข 01: เพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแต่ละกลุ่มวัย

กล่องหมายเลข 02: ป้องกันหรือลดปัญหาสาธารณสุข หรือภาระโรคที่สำคัญของประเทศ

กล่องหมายเลข 03: สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่

กล่องหมายเลข 04: เพิ่มคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ที่มา (ล่างสุด กรอบเหลือง): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์ rint ตั้ง แอนด์ พับ ลิซซิง. 2563.

==== หน้า fin_ocr.fin-28.txt ==== **หัวข้อบน (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (สีเหลือง): 4. การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กล่องซ้ายบน (สีส้ม): ค่าบริการ P&P (328.57 บาทต่อ ปชก. ทุกสิทธิ 66.0330 ล้านคน)

กล่องขวาบน: - ได้รับ 455.39 บาทต่อหัว UC pop 47.6440 ล้านคน - เป้าหมาย thai pop 66.0330 ล้านคน โดยใช้จำนวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนในการจัดสรร

แถวกล่อง 5 กล่อง (เรียงจากซ้ายไปขวา):

1. Central Procurement & NPP (30.83 บาท/คน)

บริหารจัดการระดับประเทศ - การจัดซื้อ/จัดสร้างภายในประเทศ - ค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นนโยบายหรือปัญหาสำคัญระดับประเทศ

2. P&P ในชุมชน (45 บาท/คน)

เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3. P&P Area based (4 บาท/คน)

บริหารจัดการระดับเขตให้เป็นค่าบริการที่ต้องการ เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ไขปัญหาค้นที่ระดับเขต/จังหวัด

4. P&P basic service (239.74 บาท/คน)

1. จำนวน 203.57 บาทต่อคน จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ
2. จำนวนที่เหลือ 36.17 บาทต่อคน จ่ายแบบ Free schedule

5. จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (9 บาท/คน)

1. บริการแบบ Global budget ระดับเขต
2. จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ผลงานบริการ (QOF)

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์ rint ตั้ง แอนด์ พับ ลิซซิง. 2563.

หัวข้อ (บนขวา แถบสีเหลือง): 5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

รายการที่ 1 (ไอคอนรถเข็นวีลแชร์): 1. คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการตาม
ความจำเป็นอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

รายการที่ 2 (ไอคอนผู้สูงอายุ): 2. คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

รายการที่ 3 (ไอคอนจับมือ): 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร คนพิการ องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ในการพัฒนา
รูปแบบการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนอย่างยั่งยืน

รายการที่ 4 (ไอคอนสมอง): 4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง สำหรับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) กระทบสมองบาดเจ็บ (Traumatic brain injury)
หรือ การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury)

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์ринตติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-30.txt ===== **หัวข้อยบน:** 5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
แพทย์

กล่องสีส้ม (บนสุด กึ่งกลาง): ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 18.40 บาทต่อผู้มี
สิทธิ

กล่องซ้าย (สีน้ำเงิน): กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด (ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

1. จ่ายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ที่มีความพร้อมตามประกาศหลักเกณฑ์
การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562
2. อัตราจ่ายให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย
3. ครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการตามรายการที่ สปสช. กำหนด
ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัดดำเนินการ ค่าฝึกทักษะการทำควมคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทางการเห็น

การสร้างควมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว และบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ จำตามรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการในชุมชน และอื่นๆ ตามหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด

กล่องขาว (สีชมพู/แดง): จำตามผลงานบริการ บริหารจัดการระดับจังหวัด (ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 13.40 บาท ต่อผู้มีสิทธิ)

1. ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ (ไม่ซ้ำกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด)
2. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การตีบและบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) หรือ การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury) เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างควมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว และบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ จำตามรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
3. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ จำตามระบบ Point system with ceiling ของรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
4. กรณีพื้นที่ที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ให้เพิ่มครอบคลุมการบริการค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ตามรายการที่ สปสช. กำหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดดำเนินการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างควมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว และค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้บริการในชุมชน

===== หน้า fin_ocr.fin-31.txt ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (แถบเหลือง): 6. บริการการแพทย์แผนไทย

รายการที่ 1 (ไอคอนอาคารโรงพยาบาล): 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายการที่ 2 (ไอคอนครกยาสมุนไพร): 2. เพิ่มการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

รายการที่ 3 (ไอคอนโล่และดาว 5 ดวง): 3. สนับสนุนให้หน่วยบริการจัดบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

รายการที่ 4 (ไอคอนคนฝังเข็ม/กระตุ้นไฟฟ้า): 4. บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง

ด้านล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สงครามพรีนติง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-32.txt ===== **หัวข้อบน (แถบสีน้ำเงิน):** Mahidol University Faculty of Nursing 6. บริการการแพทย์แผนไทย

กล่องสี่เหลี่ยมบนสุด (กลาง): บริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564 17.90 บาทต่อผู้มีสิทธิ UC

กล่องซ้าย (สีฟ้าอ่อน): บริการการแพทย์แผนไทย 16.30 บาทต่อผู้มีสิทธิ UC

กล่องขวา (สีเหลือง): บริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า 1.60 บาท ต่อผู้มีสิทธิ UC

กล่องล่างซ้าย (สีขาว ใต้กล่องซ้าย): จ่ายตามจำนวนผลงานบริการการแพทย์แผนไทย ตามรายการบริการดังนี้ 1. บริการนวด 2. บริการประคบ 3. บริการนวดและประคบ 4. บริการอบสมุนไพร 5. การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย 6. การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

กล่องล่างขวา ซ้าย (สีเหลือง ใต้กล่องขวา): จ่ายตามรายการบริการ ตามมาตรฐาน ชุดบริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วม กับกระตุ้นไฟฟ้า

กล่องล่างขวา ขวา (สีเหลือง ใต้กล่องขวา): จ่ายแบบเหมาจ่าย เพิ่มเติมตาม มาตรฐานบริการ ที่ สปสช.กำหนด

แถบล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สงครามพรีนติงแอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-33.txt ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้/หัวเรื่อง):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (แถบสีน้ำเงินเข้ม พร้อมเลข 7 ในวงกลมสีเหลือง): 7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะของงบลงทุน

ข้อ 1 (ไอคอนคลิปปอร์ดอากาศบาทเขียว/โล่เหลือง): 1. เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ข้อ 2 (ไอคอนรถเข็นข้อปึง/เฟื่องสีเหลือง): 2. เพื่อให้หน่วยบริการจัดหา และจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า และซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

แถบล่างสุด (ที่มา พร้อมไอคอนเอกสารสีเหลือง): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562. สหพิมพ์รึนตั้งแอนดพับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-34.txt ===== **หัวข้อบน (แถบน้ำเงินด้านบน):**

Mahidol University Faculty of Nursing

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน

กล่องเหลืองบนสุด (กลาง):

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

คำนวณตามสัดส่วนอัตราต่อผู้มีสิทธิของงบ OP-P&P-IP

สามกล่องวงกลมแถวถัดมา (ซ้าย-กลาง-ขวา):

ซ้าย: งบเบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนสำหรับบริการ **OP**

ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ

กลาง: งบเบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนสำหรับบริการ **P&P**

ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ

ขวา: งบเบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนสำหรับบริการ **IP**

ตามจำนวนผู้มารับบริการ IP (Sum adjRW ของหน่วยบริการ)

กล่องเหลืองถัดมา (กลาง):

รวมงบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่คำนวณตามสัดส่วน OP-P&P-IP (100%)

สองแถบล่างสุด (ซ้าย-ขวา):

ซ้าย (กรอบสีฟ้า): **หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.** 1. ไม่น้อยกว่า 70% จ่ายตรงให้หน่วยบริการ 2. ไม่เกิน 20% จ่ายให้หน่วยบริการตามแผนการ บริหารจัดการระดับจังหวัด 3. ไม่เกิน 10% จ่ายให้หน่วยบริการตามแผนการ บริหารจัดการระดับเขต โดยทั้ง 3 ระดับผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.

ขวา (กรอบสี่เหลี่ยม): **หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ ยกเว้น สป.สร.** ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการทั้งหมด 100% ยกเว้น ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพฯ ให้จ่าย ตามแผนของสำนักอนามัย โดยผ่านความเห็นชอบ จาก อปสข.

แถบล่างสุด (ที่มา):

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รีตติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-35.txt ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวเรื่อง (บนขวา): 8. การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย

รายการที่ 1: 1 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการ รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ

รายการที่ 2: 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด

รายการที่ 3: 3 เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในอันที่จะร่วมกันคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ สาธารณสุข

รายการที่ 4: 4 ผู้ให้บริการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

ที่มา (ด้านล่าง): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รีตติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-36.txt ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้/หัวเรื่องหน่วยงาน):**
Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (แถบเหลือง-น้ำเงิน): 9. การบริหารจัดการการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

กล่องที่ 1 (ไอคอนคนสามคน/หัวใจ): 1. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

กล่องที่ 2 (ไอคอนกราฟแท่ง/ดาว): 2. หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กล่องที่ 3 (ไอคอนจอคอมพิวเตอร์/เครื่องหมายถูก): 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบข้อมูลสุขภาพในพื้นที่

แลบล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รื้อนต้งแอนดพัลลซซซง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-37.txt ===== **มูมซ่ายบบ (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (ขวบบน): 9. การบริหารจัดการการจ่ายตามเกณฑ์ คุณภาพผลงานบริการ

รายการที่ 1: บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริการ ที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

9 บาทต่อผู้มีสิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิ 47.6440 ล้านคน

รายการที่ 2: บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

9 บาทต่อประชาชนไทยทุกคน 66.0330 ล้านคน

รายการที่ 3: บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

2 บาทต่อผู้มีสิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิ 47.6440 ล้านคน

ด้านล่าง (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์รื้อนต้ง แอนดพัลลซซซง.2563.

===== หน้า fin_ocr.fin-38.txt ===== **หัวเรื่องบบ (ซ้าย):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลาง): การจ่ายตามรายป่วย (Per-case payment)

รายการที่ 1: การจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาตามประเภทของการะโรคของผู้ป่วย โดยไม่สนใจจำนวนครั้งและรายละเอียดของการให้บริการ

รายการที่ 2: กระตุ้นให้สถานบริการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า คุ่มทุน เช่น ลดวันนอน (length of stay)

รายการที่ 3: ควบคุมต้นทุนระดับประเทศได้ดี (cost containment)

รายการที่ 4: สนับสนุนการใช้ clinical pathways

รายการที่ 5: เพิ่มความยุติธรรม เพราะจ่ายตามความซับซ้อนของโรค ไม่ใช่ปริมาณบริการ

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.2544. Health Insurance System Research Office. Thai DRG Version 6. Bangkok; 2020.

หัวข้อหลัก (บนขวา): การจ่ายตามรายป่วย (Per-case payment)

เนื้อหาหลัก (กรอบสีขาว เรียงจากบนลงล่าง):

- 1 โรงพยาบาลเสี่ยงขาดทุนในเคสหนักมาก (high severity)
- 2 กระตุ้นการ “upcoding” เพื่อเพิ่มรายรับ
- 3 เสี่ยงจำหน่ายผู้ป่วยเร็วกว่าเหมาะสม
- 4 ตัวอย่าง

| การชดเชยค่ารักษา IPD ของระบบ UC และ CSMBS ใช้ Thai DRG

ด้านล่างสุด (ที่มา): ที่มา: จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.2544.

Health Insurance System Research Office. Thai DRG Version 6. Bangkok; 2020.

หัวข้อหลัก (กลางบนสุด): กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

กล่องที่ 01: ระบบการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยระบบหนึ่ง โดยเป็นการจัดกลุ่มผู้ป่วยในที่มี**การเจ็บป่วย การรักษา และการใช้ทรัพยากร/ต้นทุน**ในการดูแลรักษาพยาบาลใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กล่องที่ 02: ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเดียวกัน จะมี**ต้นทุน**ในการดูแลรักษาพยาบาลและ**จำนวนวันนอนที่ใกล้เคียงกัน**

กล่องที่ 03: นำมาใช้ในกระบวนการการเงินการคลังสาธารณสุข ได้แก่ **การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล** เพราะเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงด้วยกันระหว่างองค์กรประกันกับสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย

ล่างซ้าย (ที่มา): ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

หัวข้อหลัก (กลางบน): กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

กรอบเนื้อหาหลัก:

✓ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai diagnosis related groups; TDRGs) ฉบับ (version) 5.1 ประกาศใช้เมื่อปี 2555 โดย สปสช. ยังคงใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดค่าใช้จ่าย

• ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (l
 ä
 u
 U
 S:
 Ä
 u
)

✓ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai diagnosis related groups; TDRGs) ฉบับ (version) 6.2 ประกาศในปี 2561 สำหรับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม

ล่างสุด (แหล่งที่มา): ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

===== หน้า fin_ocr.fin-42.txt ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: ข้อมูลที่ใช้กำหนดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

รายการกลางหน้า (กรอบใหญ่):

1. โรคหลัก (Principal Diagnosis)
2. การวินิจฉัยรอง (Secondary Diagnosis: SDx) ได้แก่ โรคแทรก (Complications) และโรคร่วม (Comorbidities)

(ข้อ 1 และ 2 มีวงเล็บเชื่อมด้านขวา ระบุว่า **ICD10**)

1. การผ่าตัดและหัตถการ -> ICD9
2. อายุของผู้ป่วย
3. ประเภทการจำหน่ายผู้ป่วย

4. จำนวนวันนอนโรงพยาบาล (Length of stay)
5. KG น้ำหนักตัวแรกรับ (Admission weight)

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

===== หน้า fin_ocr.fin-43.txt ===== **Mahidol University Faculty of Nursing**

น้ำหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight: RW)

- 1 น้ำหนักสัมพัทธ์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการใช้ทรัพยากรในการรักษาผู้ป่วย DRG นั้น เทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด
- 2 RW จึงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยของ DRG นั้นว่า เป็นที่เท่าของต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRG
- 3 คะแนนน้ำหนักสัมพัทธ์ใช้เป็นหน่วยในการคำนวณจ่ายเงินให้แก่โรงพยาบาลได้

RW = mean charge of each DRG _____
aggregated mean charge of all patients

Mean charge of each DRG คือ ค่ารักษาเฉลี่ยรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

Aggregated mean charge of all patients คือ ค่ารักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด

ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

===== หน้า fin_ocr.fin-44.txt ===== **หัวเรื่อง (ซ้ายบน):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: น้ำหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight: RW)

ข้อ 1: องค์กรประกันสุขภาพจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลคู่สัญญาสำหรับบริการผู้ป่วยใน โดยใช้ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (relative weight; RW) คูณด้วยอัตราฐาน (base rate)

ข้อ 2: ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปบริการนอกเขต จ่ายที่อัตรา 9,600 บาทต่อ AdjRW

ข้อ 3: บริการในเขตผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One day surgery) จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาท ต่อ RW

ข้อ 4: RW เป็นชุดตัวเลขที่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยให้ความสนใจมาก เพราะเป็นจำนวนเงินที่สถานพยาบาลจะได้รับตามข้อตกลงกับกองทุนประกันสุขภาพ

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562. สหพิมพ์ринตติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.2562.

===== หน้า fin_ocr.fin-45.txt ===== **หัวเรื่อง:** CaseMix Index: CMI

ข้อความ (จุดที่ 1): > CMI ถูกนำมาใช้ในการกำหนดศักยภาพของการบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สูตร (กล่องกลาง): $CMI = \frac{\text{ผลรวมของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (Sum of RW)}}{\text{จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด}}$

ข้อความ (จุดที่ 2): > กรณี CMI มีค่าน้อยกว่าในช่วง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ หรือการให้บริการผู้ป่วยในไม่เหมาะสม อาทิ อาจไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

ข้อความ (จุดที่ 3): > กรณี CMI อยู่ในช่วงหรือสูงกว่าค่าดัชนีดังกล่าว ถือว่ามีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพราะรับรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสม และ/หรือมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

===== หน้า fin_ocr.fin-46.txt ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: ค่า CMI สำหรับโรงพยาบาลระดับต่างๆ

ตาราง (หัวตาราง): ระดับบริการ | ค่าปัจจุบัน | ค่าเป้าหมาย 5 ปี

แถวข้อมูล: โรงพยาบาลศูนย์ | 1.10 - 1.55 | 1.80 - 2.00

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 0.90 - 1.20 | 1.40 - 1.50

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก | 0.65 - 1.00 | 1.10 - 1.30

โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย | 0.55 - 0.75 | 0.90 - 1.00

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ | 0.50 - 0.70 | 0.80 - 0.85

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง | 0.45 - 0.65 | 0.75 - 0.80

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก | 0.40 - 0.60 | 0.70 - 0.75

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

===== หน้า fin_ocr.fin-47.txt ===== **หัวสไลด์ (บนซ้าย):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): บริการผู้ป่วยในทั่วไปในสิทธิ UC

คำอธิบายใต้หัวข้อ: เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกรายการ

แถบสีเหลือง (กลาง): ค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,440.03 บาทต่อผู้มีสิทธิ

กล่องซ้าย (สีฟ้า): 100 ลบ. บริหารจัดการระดับประเทศ

แนวทางการจ่าย: - จ่ายเพิ่มเติม สำหรับบริการในเขตที่อัตราจ่ายระดับเขต ไม่ถึง 8,350 บาท
ต่อ adjRW ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรม- การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการ
บริหาร จัดการกองทุน กำหนด - ถ้าเงินเหลือจ่ายให้หน่วยบริการตามผลงาน

กล่องขวา (สีชมพู/แดง): ส่วนที่เหลือ บริหารจัดการระดับเขต จัดass Global
budget ระดับเขต

แนวทางการจ่าย: ใช้ DRG v5 1. การเข้ารับบริการตามมาตรา 7 (รวม UCEP) สำรองเตียง
การใช้บริการนอกเขต และ กรณีเด็กแรกเกิดที่น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม หรือเด็กแรก
เกิดที่ป่วย สถาบันว่า ODS & MIS และ Home Chemo ตามราคาที่กำหนด 2. การใช้
บริการในเขต (รวมเด็กแรกเกิดน้ำหนักมากกว่า 1,500 กรัม, ODS & MIS, และ Home
Chemo และรวมกรณีที่จะกำหนดอัตราเฉพาะเขต) - จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,350 บาท
ต่อ adjRW เท่ากันทุกเขต (ในระหว่างปี อาจปรับ อัตราจ่ายเพิ่ม ตามประมาณการผลงาน
บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ถือเป็นอัตราจ่ายเบื้องต้น) - สิ้นปี หากมีเงินเหลือ แต่ละเขตจ่าย
เพิ่มเติมตามผลงานของแต่ละหน่วยบริการ - ถ้าอัตราต่ำกว่า 8,350 บาทต่อ adjRW ให้ใช้
เงินบริหารจัดการระดับประเทศ จ่ายให้ได้ที่อัตรา 8,350 บาทต่อ adjRW

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564. สหพิมพ์เริ่มต้น แอนด์พับลิชชิ่ง.2563.

เลขหน้า (มุมขวาล่าง): 47

===== หน้า fin_ocr.fin-48.txt ===== **หัวเรื่องบน (โลโก้):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: ประโยชน์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

กล่องที่ 1: ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรเงิน การจ่ายเงิน และการประเมินผลงานการจัดบริการของโรงพยาบาล

กล่องที่ 2: การสร้างมาตรฐานการคิดค่าบริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กล่องที่ 3: ใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม

กล่องที่ 4: ใช้ในการประเมินความเป็นธรรมในการให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วย

กล่องที่ 5: ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพในแต่ละกลุ่มสิทธิ

ด้านล่างสุด: ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

===== หน้า fin_ocr.fin-49.txt ===== **หัวเรื่อง (บนสุด):** Mahidol University
Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: ปัญหาการใช้การวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

01

⚠ ปัญหา ข้อมูลในเวชระเบียนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อาทิ แพทย์ลงโรคหลักผิดพลาด ลงโรคร่วมไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ลงหัตถการ

✓ แนวทางแก้ไข ✓ ต้องปรับวิธีการเป็นการบันทึกทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะบันทึกได้ ✓ มอบหมายผู้ตรวจสอบความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ของบันทึกทางการแพทย์และ การพยาบาลในเวชระเบียน

02

⚠ ปัญหา เจ้าหน้าที่ Coding ICD 10, ICD 9 ผิดพลาด

✓ แนวทางแก้ไข ✓ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ด้านล่างสุด: ที่มา: ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย. <http://www.tcmc.or.th/main/index.php?start=18>

หัวข้อหลัก: การเปรียบเทียบระบบการจ่ายของ 3 กองทุนสุขภาพไทย

ตาราง

หัวตาราง: กองทุน | ระบบการจ่าย | จุดเด่น | จุดด้อย

แถวที่ 1: - กองทุน: CSMBS - ระบบการจ่าย: OP = FFS, IP = DRG - จุดเด่น: ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ดี - จุดด้อย: ค่าใช้จ่ายสูง เสี่ยง overuse

แถวที่ 2: - กองทุน: SSS - ระบบการจ่าย: Capitation + DRG - จุดเด่น: ควบคุมงบได้ดี - จุดด้อย: คุณภาพไม่เท่าเทียมระหว่างหน่วยบริการ

แถวที่ 3: - กองทุน: UC - ระบบการจ่าย: Capitation (OP) + DRG (IP) - จุดเด่น: สมดุล ต้นทุน-คุณภาพ - จุดด้อย: อัตราตายต่ำ

ที่มา: World Health Organization. Health financing: provider payment mechanisms. Geneva: WHO; 2022. National Health Security Office. Payment systems under the Universal Coverage Scheme. Bangkok; 2021.

===== หน้า fin_ocr.fin-51.txt ===== **หัวเรื่อง (บนสุด):** บทบาทของพยาบาลกับการเบิกจ่ายในระบบบริการ

โลโก้/มุมซ้ายบน: Mahidol University Faculty of Nursing

รายการที่ 1: บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

รายการที่ 2: สร้างความตระหนักและวัฒนธรรมของการบันทึกทางการแพทย์ และบันทึกทางการแพทย์พยาบาลที่ถูกต้อง

รายการที่ 3: จัดระบบของการตรวจสอบ ทบทวนบันทึกทางการแพทย์และ ทางพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

รายการที่ 4: ศึกษาคู่มือและทำความเข้าใจวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละกองทุน สุขภาพ และชุดสิทธิประโยชน์ในผู้ป่วย เพื่อพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ป่วย

รายการที่ 5: นำผลการวิเคราะห์การเบิกจ่าย และความคุ้มค่าคุ้มทุน และผลลัพธ์ทางการดูแลรักษา มาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย อาทิ การพัฒนาศักยภาพ การปรับวิธีการในการพยาบาล เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย